

Samowspółczucie w AvPD

Antidotum na zinternalizowany wstyd. **Trzy elementy** Neff: życzliwość, wspólna ludzkość, uważność. Kirby 2017 (metaanaliza 21 RCT): CFT redukuje wstyd i samokrytycyzm z $d \approx 0,5$.

CZAS: 12 min Codzienna praktyka **ŹRÓDŁO:** Neff (2003); Gilbert (2010); Kirby i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz, dlaczego wewnętrzny krytyk *nie motywuje* — paraliżuje (sekcja 01). **2** · Poznasz **trzy elementy** samowspółczucia Neff (sekcja 02). **3** · Wypełnisz pierwsze ćwiczenie *compassionate self-talk* (sekcja 03). **4** · Poznasz zjawisko **efekt wsteczny** (ang. *backdraft*) — dlaczego pierwsze próby *nasilają* ból i jak przez to przejść (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Samowspółczucie (Neff 2003; Gilbert 2010) jest **kluczowe w AvPD** — bo rdzeń AvPD to wstyd i samokrytycyzm. Kirby i wsp. (2017, metaanaliza 21 RCT): CFT (*Compassion-Focused Therapy*) redukuje wstyd, samokrytycyzm i depresję z $d \approx 0,5$, niezależnie od redukcji lęku. Wewnętrzny krytyk w AvPD jest *brutalny i nieprzerwany*: „głupi, nieudolny, dlaczego znowu”. Pacjent traktuje to jako **„motywację”** — a faktycznie krytyk *paraliżuje*, bo aktywuje układ zagrożenia. Wynik: mniej działania, więcej wstydu, większy krytyk. **Pętla się zaciska**. Trzy komponenty Neff: życzliwość wobec siebie (ang. *self-kindness*, zamiast osądzania), wspólna ludzkość (ang. *common humanity*, zamiast izolacji), uważność (ang. *mindfulness*, zamiast over-identyfikacji). Samowspółczucie aktywuje **układ uspokojenia** (oksytocyna, n. błędny), który fizjologicznie hamuje układ zagrożenia. To *nie tylko* „myśl pozytywnie” — to **przesunięcie autonomicznego balansu**.

01 📋 Krytyk nie motywuje — paraliżuje

MIT MOTYWUJĄCY

„Krytyka mnie *motywuje*”. Tak myśli pacjent. Realnie krytyk aktywuje układ zagrożenia → kortyzol → zamrożenie → **mniej działania**, nie więcej. Krytyk *paraliżuje*.

PĘTLA SIĘ ZACISKA

Krytyk → wstyd → unikanie → krytyk za unikanie → większy wstyd → głębsze unikanie. **Spirala**. Każda iteracja wzmacnia schemat defektywności.

Klucz: samowspółczucie *nie jest* „odpuszczeniem sobie” ani „pobłażaniem”. Jest **fizjologiczną zmianą** autonomicznego układu — z zagrożenia do uspokojenia. Pacjent uczy się odpowiadać sobie *tak jak przyjacielowi*, nie *tak jak surowemu rodzicowi*. Dopiero ta zmiana pozwala działać.

02 ☉ Trzy elementy samowspółczucia (Neff 2003)

samoOSĄDZANIE „jestem głupi, źle to zrobiłem”	IZOLACJA „tylko ja tak mam”	FUZJA Z MYŚLĄ „jestem wadliwy”
1 · ŻYCZLIWOŚĆ jak do przyjaciela	2 · WSPÓLNA LUDZKOŚĆ „nie jestem sam/-a”	3 · UWAŻNOŚĆ „mam myśl, że...”

Trzy elementy Neff: (1) życzliwość (ang. *self-kindness*) zamiast osądzania (*self-judgment*) — odpowiedz sobie tak jak odpowiedziałbyś/-abyś przyjacielowi. (2) Wspólna ludzkość (*common humanity*) zamiast izolacji — „wszyscy popełniają błędy, nie tylko ja”. (3) Uważność (*mindfulness*) zamiast over-identyfikacji — „mam *myśl*, że jestem głupi”, nie „jestem głupi”. Praktyka codzienna: *compassionate self-talk* (Gilbert) — list do siebie, kojący głos.

03 ✎ Compassionate self-talk — pierwszy zapis

CO KRYTYK POWIEDZIAŁ MI DZISIAJ?

— *dokładne słowa, ton*

CO POWIEDZIAŁ(A)BYM PRZYJACIELOWI/-ÓŁCE?

— *w tej samej sytuacji*

WSPÓLNA LUDZKOŚĆ — KTO JESZCZE TO CZUJE?

— „*nie jestem jedyny/-a, który...*”

DEFUZJA — „MAM MYŚL, ŻE...”

— *zamiast „jestem...”*

04 💡 Efekt wsteczny — gdy współczucie boli bardziej

CZYM JEST EFEKT WSTECZNY

Pierwsze próby samowspółczucia *uruchamiają* więcej wstydu i bólu („*nie zasługuję na ciepło*”). Pacjent czuje się gorzej, nie lepiej. Jest to **normalne i przewidywalne**.

JAK PRZEZ TO PRZEJŚĆ

Nie przerywać. Krótkie sesje (1–2 min). Powolny start. Przejdź dalej, nawet jeśli boli. Efekt wsteczny ustępuje po kilku tygodniach regularnej praktyki. Bez przejścia — pacjent wraca do krytyki.

Klucz: samowspółczucie *nie jest* słabością ani pobłażaniem — jest **fizjologiczną zmianą**. Aktywuje układ uspokojenia (oksytocyna, n. błędny), *hamując* układ zagrożenia. Kirby 2017: $d \approx 0,5$ dla wstydu i samokrytycyzmu, niezależnie od lęku. Trzy elementy Neff: **życzliwość, wspólna ludzkość, uważność**. Pacjent z AvPD często doświadcza efektu wstecznego (ang. *backdraft*) — pierwsze próby **nasilają** ból („*nie zasługuję*”). To normalne. Przejdź przez to. Praktyka *codzienna* (krótkie sesje), regularna, długoterminowa. Cel: odpowiadać sobie jak *przyjacielowi*, nie jak *surowemu rodzicowi*. Dopiero wtedy działanie staje się możliwe.